リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月26日（月）

第45号　朝刊

きょうの紙面　▶回復期リハ・腎機能　▶歩行評価・測定誤差　▶嚥下・代償姿勢　▶短信 8本

■ 回復期リハ・腎機能

回復期の腎機能低下 ＦＩＭ利得小さく

一日当たりの効率に有意差なし　在院期間なども検討を

研究では、２０１４～２０２３年に回復期リハ病棟へ入院した１０，８３２人、平均７３・１歳を後ろ向きに解析した。透析導入前の患者を腎機能の重症度で分け、入退院時のＦＩＭから利得、日当たりの効率、改善可能分に対する達成割合を比較した。主な比較は軽度低下までの群と、ＣＫＤステージ３ｂ～５の進行した低下群だった。

進行した低下群は、ＦＩＭ利得が１４・６対１６・９点、達成割合が０・３４対０・４０と低く、在院日数も５２・６対５９・６日と短かった。いずれもＰ＜０・００１。一方、日当たりのＦＩＭ利得を表す効率には差がなかった（Ｐ＝０・９８）。年齢や栄養、貧血など患者背景の違いにも留意が必要だ。

腎機能が低い人は一律に改善しない、とは読めない。在院期間や総リハ量の違いも関係し得るが、観察研究なので因果は決められず、入院延長の効果も示していない。腎機能だけで目標を下げず、全身状態と練習できた日数・量を併せて確認



改善の総量と日当たりの効率を分けて捉える

したい。

出典 Journal of Nephrology ↗

数字で見る

10,832人
回復期入院を後ろ向き解析

14.6点
進行した腎機能低下群のFIM利得

16.9点
軽度低下までの群のFIM利得

■ 歩行評価・測定誤差

観察歩行評価は有望 個人の変化は慎重に

神経疾患の観察歩行評価７種類について、２８論文・６３研究の測定特性を整理した。脳卒中のＷＧＳとＧ．Ａ．Ｉ．Ｔは比較的よく研究され有望だが、測定誤差が大きく、全面的な推奨に至る尺度はなかった。

著者らは両尺度の使用を集団レベルや横断評価に限るべきとする。ＷＧＳは１４項目、Ｇ．Ａ．Ｉ．Ｔは３１項目。点を同じように付けられるこ



とと、小さな変化が誤差を超えることは別だ。観察条件をそろえ、歩行速度や介助量など別の指標も合わせて変化を確かめたい。

出典 Disability and Rehabilitation ↗

■ 嚥下・代償姿勢

顎引き嚥下の効果 適応は個別に確認

構造性・神経原性の成人嚥下障害を扱う１６研究を整理した。横断研究１３本、ＲＣＴ２本、コホート１本で、１０研究が顎引きの効果を報告。成功率は１９・６～８１％と幅があり、統合した有効率ではない。

証拠の確実性は低～非常に低く、どの条件で有効かの合意もない。嚥下開始、動き、食塊や患者の条件との関連は仮説段



階だ。顎引き自体を否定せず、個別評価で役立つかを確かめる必要がある。同じ姿勢を全員に勧めず、評価結果を食事介助の職種間で共有したい。

出典 Dysphagia ↗

短信

〈上肢〉VR付き手の外骨格
脳卒中１２人が４週練習し上肢指標は改善したが、対照群のない予備評価。機器そのものの治療効果は未確定。
出典 Biomed Tech (Berl) ↗

〈連携〉腰痛のPT開始を早く
米国７４人の後ろ向き比較。統合診療経路でＰＴ開始中央値２・５対１９日。年齢差があり因果は不明。 出典 Spine J ↗

〈肩〉呼吸練習の上乗せ
凍結肩４０人のＲＣＴで外転・外旋などに改善差。痛みの治療後群間差は有意でなく、全効果を一括しない。
出典 J Back Musculoskelet Rehabil ↗

〈肘〉衝撃波とレーザー比較
運動・装具を共通にした３週間の比較で疼痛は衝撃波群が良好。握力や総合機能は群間差がなく短期の結果。
出典 J Back Musculoskelet Rehabil ↗

〈生活〉複雑な家事にも重い依存
慢性期脳卒中１００人の横断評価。細かな手の使用３５％、複雑な家事２９％、書字２８％に重い依存。
出典 Disabil Rehabil ↗

〈教育〉OT学生の車椅子研修
アラブ圏８か国２８２人の混合研究。１１７組の前後比較で知識得点が上昇したが、実技能力の検証ではない。
出典 Adv Med Educ Pract ↗

〈下肢〉NMES10試験を統合
脳卒中５７９人の統合で運動・ＡＤＬ指標は改善。抄録に信頼区間や確実性がなく、効果の幅は未確認。
出典 Am J Phys Med Rehabil ↗

〈運営〉ICU嚥下対応を可視化
ブラジル１，３１２人の記述的報告。日々の需要４５人に対応３３人で対応率７３％。比較群はなく効果は不明。
出典 Int J Qual Health Care ↗